

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

1. Tên thuốc: LOVASTATIN DWP 10mg

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

"Đã xa tầm tay trẻ em".

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng".

"Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc".

"Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

3. Thành phần công thức thuốc:

- Thành phần hoạt chất:

Lovastatin 10 mg

- Thành phần tá dược:

Lactose, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, croscarmellose natri, magnesi stearat, butylated hydroxyanisole.

4. Dạng bào chế: Viên nén.

Mô tả: Viên nén hình tròn, màu trắng, thành và cạnh viền lành lặn.

5. Chỉ định:

Điều trị bằng lovastatin nên là một thành phần của sự can thiệp nhiều yếu tố nguy cơ ở người mắc chứng rối loạn lipid máu có nguy cơ mắc bệnh mạch máu xơ vữa động mạch. Lovastatin nên được sử dụng cùng với chế độ ăn hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol như là một phần của chiến lược điều trị nhằm giảm cholesterol toàn phần và LDL-C xuống mức mục tiêu khi sự đáp ứng với chế độ ăn kiêng và các biện pháp không dùng thuốc khác là không đủ để giảm nguy cơ.

Dự phòng tiên phát bệnh tim mạch vành:

Người không có bệnh tim mạch có triệu chứng, giá trị trung bình cholesterol toàn phần và LDL-C tăng vừa và HDL-C thấp, lovastatin được chỉ định để giảm nguy cơ:

- Nhồi máu cơ tim

- Đau thắt ngực không ổn định

- Thủ tục tái tưới máu mạch vành

Bệnh tim mạch vành:

Lovastatin được chỉ định để làm chậm sự tiến triển của xơ vữa động mạch vành ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành như là một phần của chiến lược điều trị để giảm cholesterol toàn phần và LDL-C xuống mức mục tiêu.

Tăng cholesterol máu:

Điều trị bằng các chất biến đổi lipid nên là một thành phần của sự can thiệp nhiều yếu tố nguy cơ ở người có nguy cơ mắc bệnh mạch máu xơ vữa động mạch do tăng cholesterol máu. Lovastatin được chỉ định như là một biện pháp bổ sung cho chế độ ăn kiêng để giảm nồng độ cholesterol toàn phần và LDL-C ở bệnh nhân bị tăng cholesterol máu nguyên phát (tuýp Ila và IIb2), khi đáp ứng với chế độ ăn kiêng hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol và các biện pháp không dùng thuốc khác là không đủ.

Bệnh nhân vị thành niên mắc chứng tăng cholesterol gia đình di hợp tử:

Lovastatin được chỉ định là một biện pháp bổ sung cho chế độ ăn kiêng để giảm cholesterol toàn phần, LDL-C và apolipoprotein B ở nam vị thành niên và nữ bắt đầu có kinh nguyệt ít nhất một năm, từ 10 đến 17 tuổi, sau khi thử nghiệm đầy đủ của liệu pháp ăn kiêng cho thấy những phát hiện sau:

1. LDL-C vẫn lớn hơn 189 mg/dL hoặc

2. LDL-C vẫn lớn hơn 160 mg/dL và:

- Có tiền sử gia đình dương tính với bệnh tim mạch sớm hoặc

- Hai hoặc nhiều yếu tố nguy cơ CVD khác xuất hiện ở bệnh nhân vị thành niên

Khuyến cáo chung:

Trước khi bắt đầu điều trị bằng lovastatin, cần loại trừ các nguyên nhân thứ phát gây tăng cholesterol máu (ví dụ, đái tháo đường kiểm soát kém, suy giáp, hội chứng thận hư, rối loạn protein, bệnh gan tắc nghẽn, điều trị bằng thuốc khác, nghiện rượu) và một hồ sơ lipid được thực hiện để đánh giá cholesterol toàn phần, HDL-C và TG. Đối với bệnh nhân có TG dưới 400 mg/dL (dưới 4,5 mmol/L), LDL-C có thể được ước tính bằng phương trình sau:

$LDL-C = \text{cholesterol toàn phần} - [0,2 \times (TG) + HDL-C]$

Đối với nồng độ TG lớn hơn 400 mg/dL (lớn hơn 4,5 mmol/L), phương trình này kém chính xác hơn và nồng độ LDL-C nên được xác định bằng siêu ly tâm. Ở bệnh nhân tăng triglycerid máu, LDL-C có thể thấp hoặc bình thường mặc dù cholesterol toàn phần tăng cao. Trong những trường hợp như vậy, lovastatin không được chỉ định.

6. Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng:

Dùng dùng uống. Lovastatin nên được uống cùng thức ăn.

Liều dùng:

Bệnh nhân nên được áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cholesterol tiêu chuẩn trước khi sử dụng lovastatin và nên tiếp tục chế độ ăn kiêng này trong khi điều trị bằng lovastatin.

Người lớn:

Liều khởi đầu thường được đề nghị là 20 mg mỗi ngày một lần trong bữa ăn tối. Phạm vi liều khuyến cáo của lovastatin là 10 đến 80 mg/ngày với liều đơn hoặc chia thành hai lần; liều khuyến cáo tối đa là 80 mg/ngày. Liều dùng nên được cá nhân hóa theo mục tiêu điều trị được đề nghị. Bệnh nhân cần đạt được mục tiêu giảm LDL-C từ 20% trở lên nên được bắt đầu với liều lovastatin 20 mg/ngày. Một liều khởi đầu 10 mg lovastatin có thể được xem xét cho bệnh nhân cần giảm ở mức nhỏ hơn. Điều chỉnh liều nên được thực hiện trong khoảng thời gian 4 tuần trở lên.

Nồng độ cholesterol nên được theo dõi định kỳ và nên xem xét giảm liều lovastatin nếu nồng độ cholesterol giảm đáng kể dưới mức mục tiêu.

Liều dùng ở bệnh nhân dùng Danazol, Diltiazem, Dronedaron hoặc Verapamil:

Bệnh nhân sử dụng danazol, diltiazem, dronedaron hoặc verapamil đồng thời với lovastatin, điều trị nên bắt đầu với liều 10 mg lovastatin và không nên vượt quá 20 mg/ngày.

Liều dùng ở bệnh nhân dùng Amiodaron:

Bệnh nhân dùng amiodaron đồng thời với lovastatin, liều không được vượt quá 40 mg/ngày.

Bệnh nhân vị thành niên (10 đến 17 tuổi) bị tăng cholesterol máu gia đình di hợp tử:

Phạm vi liều khuyến cáo của lovastatin là 10 đến 40 mg/ngày; không dùng quá 40 mg/ngày. Các liều nên được cá nhân hóa theo mục tiêu điều trị được đề nghị.

Bệnh nhân cần đạt được mục tiêu giảm LDL-C từ 20% trở lên nên được bắt đầu với liều lovastatin 20 mg/ngày. Một liều khởi đầu 10 mg lovastatin có thể được xem xét cho bệnh nhân cần giảm ở mức

nhỏ hơn. Điều chỉnh liều nên được thực hiện trong khoảng thời gian 4 tuần trở lên.

Kết hợp điều trị hạ lipid:

Lovastatin có hiệu quả khi được sử dụng đơn lẻ hoặc đồng thời với acid bile sequestrants.

Bệnh nhân suy thận:

Ở bệnh nhân bị suy thận nặng (độ thanh thải creatinin dưới 30 ml/phút), nên tăng liều lớn hơn 20 mg/ngày cần được theo dõi cẩn thận.

7. Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh gan hoạt động hoặc sự tăng cao kéo dài không giải thích được của transaminase huyết thanh.

Sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế CYP3A4 mạnh (ví dụ: itraconazol, ketoconazol, posaconazol, các thuốc ức chế protease của HIV, boceprevir, telaprevir, erythromycin, clarithromycin, telithromycin và nefazodon).

Sử dụng kết hợp lovastatin với gemfibrozil, cyclosporin.

Mang thai và cho con bú. Xơ vữa động mạch là một quá trình mãn tính và việc ngừng sử dụng thuốc hạ lipid máu trong thời kỳ sẽ ít ảnh hưởng đến kết quả điều trị lâu dài của chứng tăng cholesterol máu nguyên phát. Hơn nữa, cholesterol và các sản phẩm khác của con đường sinh tổng hợp cholesterol là thành phần thiết yếu cho sự phát triển của thai nhi, bao gồm tổng hợp steroid và màng tế bào. Do khả năng ức chế men khử HMG-CoA như lovastatin làm giảm quá trình tổng hợp cholesterol và có thể các sản phẩm khác của quá trình sinh tổng hợp cholesterol, lovastatin bị chống chỉ định khi mang thai và cho con bú. Lovastatin chỉ nên dùng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khi những bệnh nhân này khó có khả năng thụ thai. Nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng thuốc này, nên ngưng dùng lovastatin ngay lập tức và bệnh nhân nên được thông báo về nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Bệnh cơ/Tiểu cơ vằn:

Lovastatin, giống như các chất ức chế HMG-CoA reductase khác, đôi khi gây ra bệnh cơ có biểu hiện là đau cơ, mệt mỏi hoặc yếu với creatine kinase (CK) trên mức liều giới hạn trên của mức bình thường (ULN). Bệnh cơ đôi khi có dạng tiêu cơ vân có hoặc không có suy thận cấp thứ phát tới myoglobin niệu, và trường hợp tử vong hiếm gặp đã xảy ra. Nguy cơ bệnh cơ tăng lên do nồng độ cao của hoạt động ức chế HMG-CoA reductase trong huyết tương.

Nguy cơ bệnh cơ/tiểu cơ vằn liên quan đến liều dùng.

Đã có những báo cáo hiếm hoi về bệnh cơ hoại tử qua trung gian miễn dịch (IMNM), một bệnh cơ tự miễn, liên quan đến việc sử dụng statin. IMNM được đặc trưng bởi: yếu cơ ở đầu gần và tăng creatine kinase huyết thanh, vẫn tồn tại mặc dù đã ngừng điều trị bằng statin; sinh thiết cơ cho thấy bệnh cơ hoại tử mà không bị viêm nghiêm trọng; cải thiện với các thuốc ức chế miễn dịch. Tất cả các bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng lovastatin, hoặc tăng liều lovastatin, nên được thông báo về nguy cơ bệnh cơ và được báo cáo kịp thời bất kỳ cơn đau cơ, mệt mỏi hoặc yếu cơ nào không rõ nguyên nhân nếu đi kèm với khó chịu hoặc sốt hoặc nếu có dấu hiệu và triệu chứng cơ tồn tại sau khi ngừng lovastatin. Điều trị lovastatin nên ngưng ngay lập tức nếu bệnh cơ được chẩn đoán hoặc nghi ngờ. Trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng cơ và tăng CK được giải quyết khi ngừng điều trị kịp thời. Xác định CK định kỳ có thể được xem xét ở bệnh nhân bắt đầu điều trị bằng lovastatin hoặc tăng liều, nhưng không có gì đảm bảo rằng việc theo dõi như vậy sẽ ngăn ngừa bệnh cơ.

Nhiều bệnh nhân bị tiến triển tiêu cơ vân khi điều trị bằng lovastatin đã có tiền sử bệnh lý phức tạp, bao gồm suy thận thường là hậu quả của bệnh đái tháo đường lâu dài. Bệnh nhân như vậy cần theo dõi chặt chẽ hơn. Nên ngưng điều trị lovastatin nếu nồng độ CPK tăng cao rõ rệt hoặc bệnh cơ được chẩn đoán hoặc nghi ngờ. Điều trị lovastatin cũng nên được tạm thời dừng lại ở bất kỳ bệnh nhân nào gặp phải tình trạng cấp tính hoặc nghiêm trọng có xu hướng phát triển suy thận thứ phát sau tiêu cơ vân, ví dụ, nhiễm trùng huyết; huyết áp thấp; ca phẫu thuật lớn; chấn thương; rối loạn chuyển hóa nặng, nói tiệt hoặc điếc; hoặc động kinh không kiểm soát được. Cần nhắc theo dõi creatin kinase (CK) trong huyết hợp:

+ Trước khi điều trị, xét nghiệm CK nên được tiến hành trong những trường hợp: Suy giảm chức năng thận, nhưng giảm, tiền sử bản thân hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh cơ di truyền, tiền sử bị bệnh cơ do sử dụng statin hoặc fibrat trước đó, tiền sử bệnh gan và/hoặc uống nhiều rượu, bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) có những yếu tố nguy cơ tiêu cơ vân, khả năng xảy ra tương tác thuốc và một số đối tượng bệnh nhân đặc biệt. Trong những trường hợp này nên cân nhắc lợi ích/nguy cơ và theo dõi bệnh nhân trên lâm sàng khi điều trị bằng statin. Nếu kết quả xét nghiệm CK > 5 lần giới hạn trên của mức bình thường, không nên bắt đầu điều trị bằng statin.

+ Trong quá trình điều trị bằng statin, bệnh nhân cần thông báo khi có các biểu hiện về cơ như đau cơ, cứng cơ, yếu cơ ... Khi có các biểu hiện này, bệnh nhân cần làm xét nghiệm CK để có các biện pháp can thiệp phù hợp.

Nguy cơ bệnh cơ/tiểu cơ vằn tăng lên khi sử dụng đồng thời lovastatin với những điều sau đây: Các chất ức chế mạnh CYP3A4: Lovastatin, giống như một số chất ức chế HMG-CoA reductase khác, là chất nền của cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Một số loại thuốc ức chế quá trình trao đổi chất này có thể làm tăng nồng độ lovastatin trong huyết tương và có thể làm tăng nguy cơ bệnh cơ. Chúng bao gồm itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, thuốc kháng sinh macrolide erythromycin và clarithromycin, thuốc kháng sinh ketolid telithromycin, thuốc ức chế protease HIV, boceprevir, telaprevir, thuốc chống suy nhược nefazodon hoặc sản phẩm chứa cobicistat. Kết hợp các thuốc này với lovastatin là chống chỉ định. Nếu điều trị ngắn hạn bằng thuốc ức chế CYP3A4 mạnh là không thể tránh khỏi, điều trị bằng lovastatin nên bị đình chỉ trong quá trình điều trị.

Cyclosporin, gemfibrozil: Nên tránh sử dụng kết hợp lovastatin với gemfibrozil, cyclosporin.

Các thuốc hạ lipid khác (fibrat khác hoặc lớn hơn hoặc bằng 1 g/ngày của niacin): Nên thận trọng khi kê đơn các fibrat khác hoặc liều hạ lipid (lớn hơn hoặc bằng 1 g/ngày) của niacin với lovastatin, vì các tác nhân này có thể gây ra bệnh cơ khi dùng một mình. Lợi ích của việc thay đổi nồng độ lipid bằng cách sử dụng kết hợp lovastatin với các fibrat hoặc niacin khác nên được cân nhắc cẩn thận trước các rủi ro tiềm ẩn của các phối hợp này.

Danazol, diltiazem, dronedaron hoặc verapamil với liều cao hơn lovastatin: Liều lovastatin không được vượt quá 20 mg mỗi ngày ở bệnh nhân dùng thuốc đồng thời với danazol, diltiazem, dronedaron hoặc verapamil. Lợi ích của việc sử dụng lovastatin ở bệnh nhân dùng danazol, diltiazem, dronedaron hoặc verapamil nên được cân nhắc cẩn thận trước rủi ro của những phối hợp này.

Amiodaron: Liều lovastatin không được vượt quá 40 mg mỗi ngày ở bệnh nhân dùng thuốc đồng thời với amiodaron. Nên tránh sử dụng kết hợp lovastatin với liều cao hơn 40 mg mỗi ngày với amiodaron trừ khi lợi ích lâm sàng có khả năng cao hơn nguy cơ mắc bệnh cơ. Nguy cơ bệnh cơ/tiểu cơ vằn tăng lên khi sử dụng đồng thời amiodaron với một thuốc có liên quan chặt chẽ với nhóm thuốc ức chế HMG-CoA reductase ở liều cao hơn.

Colchicin: Các trường hợp bệnh cơ, bao gồm tiêu cơ vân, đã được báo cáo với lovastatin phối hợp với colchicin, và nên thận trọng khi kê đơn lovastatin với colchicin.

Ranolazin: Nguy cơ bệnh cơ, bao gồm cả tiêu cơ vân, có thể tăng lên khi dùng đồng thời ranolazin. Điều chỉnh liều của lovastatin có thể được xem xét trong quá trình phối hợp với ranolazin.

Việc sử dụng đồng thời các thuốc hạ lipid máu nhóm statin với các thuốc điều trị HIV và viêm gan siêu vi C (HCV) có thể làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ, nghiêm trọng nhất là tiêu cơ vân, thận hư dẫn đến suy thận và có thể gây tử vong.

Rối loạn chức năng gan:

Sự gia tăng đáng kể (đến hơn 3 lần giới hạn trên của mức bình thường) trong transaminase huyết thanh xảy ra ở 1,9% bệnh nhân trưởng thành đã dùng lovastatin trong ít nhất một năm trong các thử nghiệm lâm sàng sớm. Khi thuốc bị gián đoạn hoặc ngưng sử dụng ở những bệnh nhân này, nồng độ transaminase thường giảm từ từ xuống mức trước điều trị. Sự gia tăng thường xuất hiện 3 đến 12 tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng lovastatin và không liên quan đến vàng da hoặc các dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng khác. Không có bằng chứng về quá mẫn cảm. Trong nghiên cứu EXCEL, tỷ lệ tăng transaminase huyết thanh kéo dài trong 48 tuần là 0,1% đối với giả dược, 0,1% ở 20 mg/ngày, 0,9% ở 40 mg/ngày và 1,5% ở 80 mg/ngày ở bệnh nhân dùng lovastatin. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm sau tiếp thị với lovastatin, bệnh gan có triệu chứng đã được báo cáo hiếm gặp ở tất cả các liều.

Trong AFCAPS/TexCAPS, số lượng người tham gia có mức tăng liên tiếp alanin aminotransferase (ALT) hoặc aspartat aminotransferase (AST) (lớn hơn 3 lần so với giới hạn trên bình thường), không vượt quá 5,1, năm theo dõi khác biệt đáng kể giữa nhóm lovastatin và giả dược (18 [0,6%] so với 11 [0,3%]). Liều khởi đầu của lovastatin là 20 mg/ngày; 50% số người tham gia điều trị bằng lovastatin được điều chỉnh đến 40 mg/ngày vào tuần 18. Trong số 18 người tham gia dùng lovastatin với mức tăng liên tiếp của ALT hoặc AST, 11 (0,7%) xảy ra ở những người tham gia dùng 20 mg/ngày, trong khi 7 (0,4%) xảy ra ở những người tham gia được chuẩn độ tới 40 mg/ngày. Transaminase tăng cao dẫn đến việc ngừng tham gia trị liệu của 6 (0,2%) người trong nhóm lovastatin (n = 3,304) và 4 (0,1%) trong nhóm giả dược (n = 3,301).

Nên xét nghiệm enzym gan trước khi bắt đầu điều trị bằng lovastatin và lặp lại theo chỉ định lâm sàng.

Đã có những báo cáo hiếm gặp sau tiếp thị về suy gan gây tử vong và không gây tử vong ở bệnh nhân dùng statin, bao gồm cả lovastatin. Nếu tổn thương gan nghiêm trọng với các triệu chứng lâm sàng và/hoặc tăng bilirubin máu hoặc vàng da xảy ra trong khi điều trị bằng lovastatin, điều trị cần dừng lại kịp thời. Nếu không tìm thấy nguyên nhân thay thế, không bắt đầu lại lovastatin. Thuốc nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân sử dụng một lượng lớn rượu và/hoặc có tiền sử bệnh gan. Bệnh gan hoạt động hoặc tăng transaminase không chỉ thích được là chống chỉ định với việc sử dụng lovastatin.

Tăng transaminase huyết thanh mức độ trung bình (ít hơn ba lần giới hạn trên của mức bình thường) đã được báo cáo sau khi điều trị bằng lovastatin. Những thay đổi này xuất hiện ngay sau khi bắt đầu điều trị bằng lovastatin, thường thoáng qua, không kèm theo bất kỳ triệu chứng nào và không cần phải ngừng điều trị.

Sử dụng cho trẻ em:

An toàn và hiệu quả ở bệnh nhân từ 10 đến 17 tuổi với heFH đã được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát trong thời gian 48 tuần ở trẻ vị thành niên nam và các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát trong thời gian 24 tuần ở những trẻ nữ sau khi bắt đầu có kinh nguyệt ít nhất 1 năm. Bệnh nhân được điều trị bằng lovastatin có hồ sơ kinh nghiệm bất lợi tương đương tự như bệnh nhân được điều trị bằng giả dược. Liều lớn hơn 40 mg đã không được nghiên cứu trong nhóm này. Trong các nghiên cứu có kiểm soát hạn chế này, không có tác động có thể phát hiện được đối với sự tăng trưởng hoặc trưởng thành sinh dục ở trẻ vị thành niên nam hoặc về chiều dài chu kỳ kinh nguyệt ở trẻ nữ. Bệnh nhân vị thành niên (từ 10 đến 17 tuổi) bị tăng cholesterol máu gia đình di hợp tử. Nữ giới vị thành niên nên được tư vấn về các phương pháp tránh thai thích hợp trong khi điều trị bằng lovastatin. Lovastatin không được nghiên cứu ở bệnh nhân trước tuổi dậy thì hoặc bệnh nhân dưới 10 tuổi.

Người cao tuổi:

Một nghiên cứu được động học với lovastatin cho thấy nồng độ trung bình của hoạt động ức chế HMG-CoA reductase trong huyết tương cao hơn khoảng 45% ở bệnh nhân cao tuổi từ 70 đến 78 tuổi so với bệnh nhân từ 18 đến 30 tuổi; tuy nhiên, kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng ở người cao tuổi chỉ ra rằng điều chỉnh liều dựa trên sự khác biệt được động học lớn quan đến tuổi này là không cần thiết. Trong hai nghiên cứu lâm sàng lớn được thực hiện với lovastatin (EXCEL và AFCAPS/TexCAPS), 21% (3094/14850) bệnh nhân lớn hơn hoặc bằng 65 tuổi. Hiệu quả hạ lipid máu với lovastatin ít nhất là tương đương ở bệnh nhân cao tuổi so với bệnh nhân trẻ tuổi và không có sự khác biệt chung về an toàn trong khoảng liều 20 đến 80 mg/ngày. Bởi vì tuổi cao (lớn hơn hoặc bằng 65 tuổi) là yếu tố ảnh hưởng đến bệnh cơ, bao gồm tiểu cơ vân, lovastatin nên được chỉ định thận trọng ở người cao tuổi.

Lactose: Thuốc có chứa lactose. Bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoặc rối loạn chuyển hóa glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Mang thai

Lovastatin chống chỉ định trong thai kỳ.

An toàn ở phụ nữ mang thai chưa được thiết lập. Không có thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát với lovastatin đã được thực hiện ở phụ nữ mang thai. Đã có những báo cáo hiếm hoi về những bất thường bẩm sinh trong tử cung sau khi tiếp xúc với thuốc ức chế HMG-CoA reductase. Trong một phân tích của khoảng 200 trường hợp mang thai ở phụ nữ được điều trị bằng lovastatin hoặc một chất ức chế HMG-CoA reductase khác có liên quan chặt chẽ, tỷ lệ bất thường bẩm sinh được so sánh với tỷ lệ mắc trong dân số nói chung. Số lượng mang thai là đủ theo thống kê để loại trừ sự gia tăng 2,5 lần hoặc lớn hơn trong các bất thường bẩm sinh liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh nói chung. Mặc dù không có dấu hiệu khác biệt về tỷ lệ mắc các bất thường bẩm sinh ở trẻ sinh ra từ bệnh nhân sử dụng lovastatin hoặc một chất ức chế HMG-CoA reductase khác và tỷ lệ mắc trong dân số nói chung, việc điều trị cho mẹ bằng lovastatin có thể làm giảm nồng độ mevalonat của thai nhi, là giai đoạn tiền thân trong sinh tổng hợp cholesterol. Cơ cũng động mạch là một quá trình mãn tính và việc rút các chất làm giảm lipid trong thai kỳ có thể không có ảnh hưởng đáng chú ý đến kết quả điều trị lâu dài của chứng tăng cholesterol máu nguyên phát. Do đó, lovastatin không nên được sử dụng ở phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cố gắng mang thai hoặc nghi ngờ có thai. Điều trị bằng lovastatin nên được đình chỉ trong khi mang thai hoặc cho đến khi được xác định rằng phụ nữ không mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Người ta không biết liệu lovastatin hoặc các chất chuyển hóa của nó được bài tiết vào sữa mẹ. Vì nhiều loại thuốc được bài tiết vào sữa mẹ có nguy cơ tiềm ẩn những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng, phụ nữ dùng lovastatin không nên cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Lovastatin không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Tuy nhiên, khi lái xe hoặc vận hành máy móc, cần phải tính đến việc chống mất đã được báo cáo hiếm gặp xảy ra trong các kinh nghiệm sau tiếp thị.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác CYP3A4

Lovastatin được chuyển hóa bởi CYP3A4 nhưng không có hoạt tính ức chế CYP3A4; do đó, nó sẽ không ảnh hưởng đến nồng độ trong huyết tương của các thuốc khác được chuyển hóa bởi CYP3A4. Các chất ức chế mạnh CYP3A4 (ví dụ, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin, telithromycin, các chất ức chế protease HIV, boceprevir, telithromycin, nefazodone, erythromycin và sản phẩm chứa cobicistat) và nước bưởi làm tăng nguy cơ bệnh cơ bằng cách giảm đào thải lovastatin.

Tương tác với các loại thuốc hạ lipid máu có thể gây ra bệnh cơ

Tăng nguy cơ tổn thương cơ khi sử dụng statin đồng thời với các thuốc sau:

- Gemfibrozil
- Các thuốc hạ cholesterol máu nhóm fibrat khác
- Niacin liều cao (> 1 g/ngày)
- Colchicin

Tương tác thuốc khác

Cyclosporin, Gemfibrozil: Tránh sử dụng đồng thời lovastatin với cyclosporin, gemfibrozil.

Nước ép bưởi: Tránh dùng lượng lớn nước ép bưởi (Grapefruit juice) (>1 lít/ngày).

Cyclosporin: Nguy cơ bệnh cơ/tiểu cơ vân tăng lên khi sử dụng đồng thời cyclosporin.

Danazol, Diltiazem, Dronedaron hoặc Verapamil: Nguy cơ mắc bệnh cơ/tiểu cơ vân tăng lên khi sử dụng đồng thời thuốc danazol, diltiazem, dronedaron hoặc verapamil, đặc biệt với liều cao của lovastatin. Không dùng quá 20 mg lovastatin/ngày khi sử dụng đồng thời với danazol, diltiazem, dronedaron và verapamil.

Amiodaron: Nguy cơ bệnh cơ/tiểu cơ vân tăng lên khi sử dụng amiodaron đồng thời với một thuốc có liên quan chặt chẽ với nhóm thuốc ức chế men khử HMG-CoA. Không dùng quá 40 mg lovastatin/ ngày khi sử dụng đồng thời với amiodaron.

Thuốc chống đông máu Coumarin: Trong một thử nghiệm lâm sàng nhỏ trong đó lovastatin được dùng cho bệnh nhân điều trị bằng warfarin, không có ảnh hưởng đến thời gian prothrombin được phát hiện. Tuy nhiên, một chất ức chế HMG-CoA reductase khác đã được tìm thấy để tạo ra sự gia tăng ít hơn hai giây trong thời gian prothrombin ở tình nguyện viên khỏe mạnh dùng liều thấp warfarin. Ngoài ra, chảy máu và/hoặc tăng thời gian prothrombin đã được báo cáo ở một số bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu coumarin đồng thời với lovastatin. Khuyến cáo với bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu, thời gian prothrombin được xác định trước khi bắt đầu lovastatin và thường xuyên trong thời gian điều trị sớm để đảm bảo rằng không có sự thay đổi đáng kể về thời gian prothrombin. Khi thời gian prothrombin ổn định đã được ghi nhận, thời gian prothrombin có thể được theo dõi theo các khoảng thời gian thường được khuyến cáo cho bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu coumarin. Nếu thay đổi liều lovastatin, quy trình tương tự nên được lặp lại. Liệu pháp lovastatin không liên quan đến chảy máu hoặc thay đổi thời gian prothrombin ở bệnh nhân không dùng thuốc chống đông máu.

Ranolazin: Nguy cơ bệnh cơ, bao gồm cả tiểu cơ vân, có thể tăng lên khi dùng đồng thời ranolazin. **Pravastatinolol:** Ở người tình nguyện bình thường, không có tương tác được động học hoặc được lực học có ý nghĩa lâm sàng với việc sử dụng đồng thời một liều lovastatin và pravastatinolol.

Digoxin: Ở bệnh nhân bị tăng cholesterol máu, sử dụng đồng thời lovastatin và digoxin không ảnh hưởng đến nồng độ digoxin trong huyết tương.

Thuốc hạ đường huyết đường uống: Trong các nghiên cứu được động học của lovastatin ở bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulin, không có tương tác thuốc với glipizid hoặc với chlorpropamid.

Chức năng nội tiết:

Tăng HbA1c và nồng độ glucose huyết thanh lúc đói đã được báo cáo với các chất ức chế HMG-CoA reductase, bao gồm cả lovastatin.

Các chất ức chế HMG-CoA reductase can thiệp vào quá trình tổng hợp cholesterol và do đó về mặt lý thuyết có thể làm giảm sản xuất tuyến thượng thận và/hoặc tuyến sinh dục. Kết quả của các tác nghiệm lâm sàng với các thuốc trong nhóm này không nhất quán về tác dụng của thuốc đối với nồng độ steroid cơ bản và dự trữ. Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng lovastatin không làm giảm nồng độ cortisol huyết tương cơ bản hoặc làm suy giảm dự trữ tuyến thượng thận và không làm giảm nồng độ testosterone trong huyết tương cơ bản. Một chất ức chế HMG-CoA reductase khác đã được chứng minh là làm giảm đáp ứng testosterone trong huyết tương với HCG. Trong cùng một nghiên cứu, đáp ứng testosterone trung bình với HCG giảm nhẹ nhưng không giảm đáng kể sau khi điều trị bằng lovastatin 40 mg mỗi ngày trong 16 tuần ở 21 nam giới. Tác dụng của thuốc ức chế HMG-CoA reductase đối với khả năng sinh sản của nam giới chưa được nghiên cứu ở

số lượng bệnh nhân nam đủ. Các tác động, nếu có, trên trục tuyến yên ở phụ nữ tiền mãn kinh là không rõ. Bệnh nhân được điều trị bằng lovastatin phát triển bằng chứng lâm sàng về rối loạn chức năng nội tiết nên được đánh giá một cách thích hợp. Thận trọng nếu thuốc ức chế HMG-CoA reductase hoặc tác nhân khác được sử dụng để giảm nồng độ cholesterol được dùng cho bệnh nhân cũng đang dùng các loại thuốc khác (ví dụ: spironolacton, cimetidin) có thể làm giảm nồng độ hoặc hoạt động của hormon steroid nội sinh.

Thuốc ức chế protease HIV (kháng retrovirus): Phối hợp lovastatin với thuốc ức chế protease HIV (amprenavir, atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir) có thể làm tăng nồng độ các thuốc hạ lipid máu trong huyết tương làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ, nghiêm trọng nhất là tiểu cơ vân, thận hư dẫn đến suy thận và có thể gây tử vong. Chống chỉ định dùng phối hợp các thuốc ức chế protease HIV với lovastatin.

Thuốc ức chế protease HCV (kháng retrovirus): Phối hợp lovastatin với boceprevir hoặc telaprevir làm tăng nồng độ thuốc hạ lipid huyết trong huyết tương, dẫn đến làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ, nghiêm trọng nhất là tiểu cơ vân, thận hư dẫn đến suy thận và có thể gây tử vong. Chống chỉ định phối hợp boceprevir hoặc telaprevir với lovastatin hoặc simvastatin.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR):

Thường gặp (1/10 ≥ ADR > 1/100)

- Chuyển hóa: Rối loạn tiêu hóa.
- Thần kinh: Chóng mặt, nhức đầu.
- Mắt: Nhìn mờ.
- Tiêu hóa: Đau hơi, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, khó tiêu, đau bụng.
- Da: Phát ban.
- Cơ xương: Chuột rút, đau cơ.
- Ít gặp (1/100 ≥ ADR > 1/1000)**
- Tâm thần: Mất ngủ, khó ngủ.
- Thần kinh: Loạn vị giác.
- Da: Ngứa, khô miệng.
- Toàn thân: Mệt mỏi.

Hiếm gặp (1/1000 ≥ ADR > 1/10000)

- Miễn dịch: Hội chứng quá mẫn liên quan đến một hoặc nhiều triệu chứng sau: sốc phản vệ, phù mạch, hội chứng giống lupus, viêm da cơ, viêm bì cơ, viêm mạch, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu ái toan, thiếu máu tán huyết, kháng thể kháng nhân dương tính (ANA), tăng tốc độ lắng, viêm khớp, đau khớp, nổi mề đay, suy nhược, sốt, đỏ bừng mặt, ớn lạnh, khó thở và khó chịu.
- Chuyển hóa: Chán ăn.
- Tâm thần: Rối loạn tâm lý bao gồm bốn chấn/lo lắng.
- Thần kinh: Bệnh lý thần kinh ngoại biên đặc biệt nếu được sử dụng trong một thời gian dài, dị cảm, suy giảm chức năng nhận thức.
- Tiêu hóa: Nôn.
- Gan mật: Viêm gan, vàng da ứ mật.
- Da: Rung tóc, hoại tử biểu bì nhiễm độc và ban đỏ dạng bao gồm hội chứng Stevens-Johnson.
- Cơ xương: Bệnh nhược cơ và tiểu cơ vân, rối loạn cương dương.
- Điều tra nghiên cứu: Tăng rõ ràng và liên tục nồng độ transaminase huyết thanh. Những bất thường khác trong các xét nghiệm chức năng gan, bao gồm tăng phosphatase kiềm và bilirubin đã được báo cáo. Tăng nồng độ CK trong huyết thanh đã được nhìn thấy. Chứng thường nhẹ và thoáng qua; tăng đáng kể chỉ xảy ra trong những trường hợp hiếm.
- Nội tiết: Tăng HbA1c và tăng đường huyết.

Chưa rõ tần số:

- Tâm thần: Phiền muộn.
- Thần kinh: Suy giảm trí nhớ.

13. Quá liều và cách xử trí:

Cho đến khi có thêm kinh nghiệm về quá liều lovastatin, không thể điều trị cụ thể. Các biện pháp chung cho quá liều nên được áp dụng và chức năng gan nên được theo dõi.

Khả năng thảm tác của lovastatin và các chất chuyển hóa của nó hiện chưa được biết.

Năm tình nguyện viên khỏe mạnh đã dùng tới 200 mg lovastatin với một liều duy nhất mà không có tác dụng phụ đáng kể về mặt lâm sàng. Một vài trường hợp quá liều đã được báo cáo. Không ai trong số các bệnh nhân có triệu chứng cụ thể, và tất cả đều hồi phục mà không để lại di chứng. Liều cao nhất là 5-6 g.

14. Đặc tính được lực học:

Nhóm được lực học: Các chất làm giảm lipid huyết thanh- Thuốc ức chế HMG CoA reductase.

Mã ATC: C10AA02

Lovastatin, một lacton không hoạt động, bị thủy phân sau khi uống thành β-hydroxyacid tương ứng. Đây là chất chuyển hóa chính và là chất ức chế 3-hydroxy-3- methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, một loại enzym xúc tác bước đầu tiên và hạn chế tốc độ trong quá trình sinh tổng hợp cholesterol. Trong các thử nghiệm lâm sàng lovastatin làm giảm nồng độ của cholesterol toàn phần và LDL-C và VLDL-C (lipoprotein tỷ trọng thấp và tỷ trọng rất thấp) và cũng làm tăng HDL-C (lipoprotein tỷ trọng cao) và giảm triglycerid huyết tương.

Dạng hoạt động của lovastatin là một chất ức chế đặc hiệu của HMG-CoA reductase, enzym xúc tác quá trình chuyển đổi HMG-CoA thành mevalonat. Vì việc chuyển đổi HMG-CoA thành mevalonat là bước đầu tiên trong quá trình sinh tổng hợp cholesterol, điều trị bằng lovastatin được cho là không gây ra sự tích tụ của bất kỳ sterol độc hại nào. Hơn nữa, HMG-CoA nhanh chóng được chuyển đổi thành acetyl-CoA, tham gia vào nhiều quá trình sinh tổng hợp trong cơ thể.

15. Đặc tính được động học:

Trong các nghiên cứu sau khi uống lovastatin trên động vật, đã cho thấy tính chọn lọc cao đối với gan, trong đó lovastatin có thể được đo ở nồng độ cao hơn nhiều so với các mô khác. Lovastatin trải qua quá trình chuyển hóa lần đầu ở gan, vị trí hoạt động chính của hoạt chất, với sự bài tiết tiếp theo trong mật. Sau khi uống lovastatin cho các đối tượng thử nghiệm, 10% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu và 83% qua phân. Cả lovastatin và β-hydroxyacid của nó đều gắn với protein huyết tương của người (> 95%). Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng lovastatin vượt qua hàng rào máu/ não và hàng rào nhau thai. Nồng độ đỉnh của lovastatin trong huyết tương và các chất chuyển hóa hoạt động của nó đạt được trong quá trình 2 - 4 giờ sau khi dùng. Nồng độ tuyến tính trong huyết tương được nhìn thấy lên đến liều 120 mg lovastatin. Với liều dùng hàng ngày, nồng độ trong huyết tương ở trạng thái ổn định đạt được sau 2-3 ngày. Dùng lovastatin khi đói, nồng độ lovastatin và các chất chuyển hóa hoạt động tương ứng với 2/3 nồng độ trong huyết tương thu được khi dùng ngay sau bữa ăn bình thường.

Nguy cơ bệnh cơ tăng lên trong trường hợp nồng độ cao của chất ức chế HMG-CoA reductase trong huyết tương. Các chất ức chế CYP3A4 mạnh có thể làm tăng nồng độ trong huyết tương của chất ức chế HMG-CoA reductase và làm tăng nguy cơ bệnh cơ.

Đối tượng đặc biệt:

Người cao tuổi:

Không quan sát thấy sự khác biệt tổng thể về hiệu quả hoặc độ an toàn giữa nhóm bệnh nhân này và bệnh nhân trẻ tuổi. Tuy các dữ liệu lâm sàng được báo cáo khác không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân trẻ tuổi, nhưng không thể loại trừ sự nhạy cảm cao hơn ở một số người cao tuổi.

Trẻ em:

Dữ liệu được động học ở trẻ em không có sẵn.

Giới tính:

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các thông số được động học giữa nam và nữ.

Suy thận:

Trong một nghiên cứu trên bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin 10 - 30 ml/phút), nồng độ trong huyết tương của lovastatin sau một liều duy nhất cao hơn xấp xỉ hai lần so với người tình nguyện khỏe mạnh.

Thảm tác máu:

Ảnh hưởng của thảm tác máu đối với nồng độ lovastatin trong huyết tương và các chất chuyển hóa của nó chưa được nghiên cứu.

Suy gan:

Không có nghiên cứu được động học nào được tiến hành ở bệnh nhân suy gan.

16. Quy cách đóng gói:

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.**

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM WEALPHAR
Địa chỉ: Lô CNS, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 0914.061.682